

Rôle du secteur de la santé en matière de soutien aux parents et aux aidants pour leur permettre de réaliser leur potentiel parental



Contexte

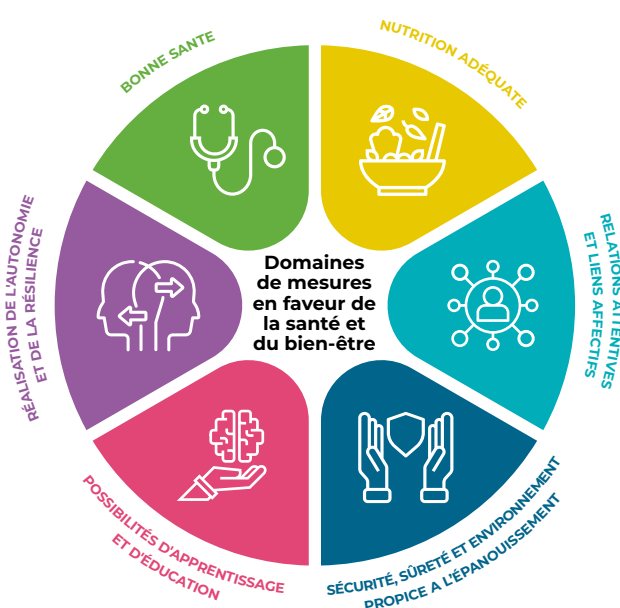
Pour aider les parents et les aidants, il convient d'adopter une approche mobilisant l'ensemble de la société, avec des actions coordonnées des secteurs de la santé, de l'éducation, des services sociaux, du secteur privé et d'autres secteurs. La présente note porte particulièrement sur le rôle du secteur de la santé.

Le système de santé a toujours apporté un soutien précieux aux parents et aux aidants dans les domaines clés de la santé et du bien-être des enfants et des adolescents (figure 1).

Cette note explique les raisons pour lesquelles le secteur de la santé devrait appuyer les parents et aidants, décrit le type de soutien dont ils ont besoin et énonce les principales composantes de l'action du secteur de la santé. Les annexes comprennent des exemples de ce que les prestataires de services peuvent faire, ainsi que des lignes directrices, des publications et des modules de formation pertinents de l'Organisation mondiale

de la Santé pouvant servir à renforcer les systèmes de santé afin de mieux soutenir les aidants et de les accompagner dans leur parcours de parents.

Figure 1. Les six domaines de la santé et du bien-être des enfants et des adolescents



Source : (1)

Principales définitions

- **Les parents et les aidants (ou personnes ayant la charge d'un enfant)** désignent les adultes qui prodiguent les soins et le soutien dont un enfant ou un adolescent/une adolescente a besoin au quotidien. Les personnes qui s'occupent à titre principal des enfants incluent les parents, la famille et les autres personnes qui sont directement responsables de l'enfant ou de l'adolescent/adolescente à la maison.
- **La parentalité** est un processus humain fondamental qui contribue à assurer le bien-être physique, émotionnel, financier et psychologique des enfants et des jeunes. Elle englobe les interactions, les comportements, les émotions, les connaissances, les croyances, les attitudes et les pratiques en lien avec la fourniture de soins attentifs. La parentalité doit toujours être replacée dans le contexte et la culture dans lesquels vivent les familles.
- Dans le présent document, les termes **parents et aidants** désignent la personne et **parentalité** (ou le fait d'avoir la charge d'un enfant) les interactions, les comportements, les émotions, les connaissances, les croyances, les attitudes et les pratiques associés au fait de s'occuper d'un enfant ou d'un adolescent/une adolescente.
- Le **soutien à la parentalité** est un ensemble d'activités structurées qui visent à aider les parents/aidants à améliorer les interactions parent-enfant et la qualité globale de la relation parentale.

Pourquoi le secteur de la santé devrait-il aider les parents et les aidants ?

La parentalité est un accélérateur essentiel de résultats positifs pour les enfants et les adolescents (2,3,4). Le fait d'apporter un soutien aux aidants peut :

- améliorer la santé physique et mentale
- améliorer le développement de l'enfant et de l'adolescent
- augmenter le salaire et la productivité
- améliorer les résultats scolaires
- accroître la cohésion sociale
- réduire les cycles de violence

De quel type de soutien les parents et les aidants ont-ils besoin ?

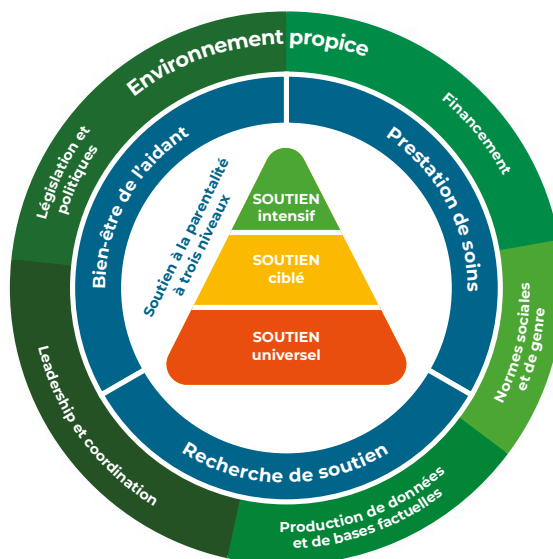
Le soutien aux aidants doit s'attacher à :

- **renforcer les comportements parentaux** : donner aux personnes s'occupant d'un enfant ou d'un adolescent/une adolescente les moyens de lui fournir des soins attentifs,
- **promouvoir la recherche de soutien** : faire connaître les services et le soutien disponibles et
- **favoriser le bien-être des aidants** : contribuer au bien-être des personnes s'occupant d'un enfant et les aider à donner la priorité à leur propre santé physique et mentale.



La figure 2 présente les principaux éléments constitutifs du soutien aux personnes ayant la charge d'un enfant ou d'un adolescent/une adolescente tout au long de la vie : services existants, soutien à la parentalité à trois niveaux et environnement favorable.

Figure 2. Principaux éléments permettant d'apporter un soutien aux personnes ayant la charge d'enfants ou d'adultes



Source : D'après Parenting support framework for the early years, UNICEF Europe et Asie centrale (5).

1 Services existants

Le secteur de la santé devrait tirer parti des possibilités offertes par les services existants pour renforcer les comportements parentaux, la recherche de soutien et le bien-être des aidants tout au long de la vie. On peut s'appuyer sur les services proposés dans les établissements, les collectivités et les écoles afin d'y inclure :

- la prise en compte des préoccupations des parents, des enfants ou des adolescents ;
- l'évaluation psychosociale et environnementale ;
- un examen physique complet, y compris le suivi de la croissance et du développement ;
- le dépistage/la détection d'affections pertinentes ;
- le conseil et la mise en œuvre d'interventions pertinentes ;
- des conseils préventifs ; et
- un soutien supplémentaire ou une orientation vers des services plus spécialisés au besoin.

2 Soutien à la parentalité à trois niveaux

Le secteur de la santé devrait adapter le niveau de soutien que les

personnes qui s'occupent d'un enfant reçoivent à l'intensité de leurs besoins (6). Toutes les personnes en charge d'un enfant peuvent bénéficier d'un soutien universel pour améliorer les comportements parentaux, la recherche de soutien et le bien-être. Cependant, les services devraient également repérer les personnes qui ont besoin de davantage de soutien et faciliter l'établissement de liens avec des interventions plus intensives, des services spécialisés au sein du système de santé ou des services fournis par d'autres secteurs au besoin. Les trois niveaux de soutien à la parentalité sont présentés sur la figure 2 et décrits ci-dessous.

- Un **soutien universel**, afin d'améliorer les comportements parentaux, la recherche de soutien et le bien-être, consiste notamment à promouvoir une parentalité positive au moyen d'informations, de conseils et de modèles comportementaux lors des visites de routine.
- Un **soutien ciblé** pour les personnes présentant des besoins spécifiques, par exemple des groupes de soutien communautaires pour les personnes dans des situations de crise humanitaire.
- Un **soutien intensif** pour les personnes présentant des besoins complexes, par exemple un accompagnement individualisé pour les personnes s'occupant d'un enfant ayant des troubles du développement.

3 Un environnement favorable

Le secteur de la santé devrait collaborer avec d'autres services et secteurs de sorte à créer un environnement favorable pour les personnes qui s'occupent d'un enfant (voir cercle extérieur sur la figure 2). Cela repose sur un cadre législatif et politique complet, des mécanismes de coordination efficaces, un financement adéquat, une production de données et de preuves solides, et la promotion de normes sociales et de genre favorables. L'accès à l'information, aux ressources et à des services de qualité dans les systèmes de santé, d'éducation et de protection sociale est essentiel au réseau de soutien dont les parents ont besoin (7).



Comment le secteur de la santé devrait-il soutenir les parents et les aidants ?

Pour s'assurer que les services de santé soutiennent les parents et les personnes qui s'occupent d'un enfant, le secteur de la santé devrait utiliser trois principes : se souvenir, renforcer et étoffer.



Rappeler

Une grande partie de ce que font déjà les prestataires de services de santé est conçue pour soutenir les personnes qui s'occupent d'un enfant et les parents.

Exemples :

- Remarquez qu'une femme enceinte a l'air anxieux lors d'un examen de routine et encouragez-la à demander de l'aide.
- Aidez les jeunes parents à établir un contact visuel pendant l'allaitement.
- Répondez aux préoccupations concernant la préparation de l'enfant à l'école.
- Guidez les personnes en charge d'un enfant sur la façon de discuter des changements liés à la puberté et de la santé menstruelle avec l'adolescent ou l'adolescente dont elles s'occupent.

Renforcer

Lorsque les services existants sont renforcés et dispensés avec une qualité élevée, cela réduit le besoin futur de recherche d'aide ou de traitement.

Exemples :

- Assurez-vous que toutes les interactions avec les parents et les personnes en charge d'un enfant sont bienveillantes et respectueuses, qu'elles s'appuient sur les points forts existants et qu'elles apportent des réponses encourageantes et non moralisatrices à leurs préoccupations.
- Créez des possibilités de suivi au moyen d'échanges ou de messages personnalisés pour les parents et les personnes en charge d'un enfant qui ont manqué des rendez-vous ou les familles qui ont besoin d'un soutien supplémentaire.

Compléter

Des actions de petite envergure mais efficaces (« solutions rapides ») peuvent s'ajouter aux services existants afin d'optimiser le soutien que reçoivent les personnes qui s'occupent d'un enfant et ce dernier. Ces ajouts n'ont pas besoin d'être compliqués ou coûteux.

Exemples :

- Lors d'une échographie au troisième trimestre, attirez l'attention des parents sur la capacité du bébé à reconnaître la voix de ses parents dans l'utérus.
- Montrez aux parents comment réagir avec empathie et bienveillance face à la peur de l'aiguille que manifeste leur enfant lors d'une vaccination.
- Fournir un réseau WIFI de base auquel les patients peuvent se connecter, les inciter à renseigner leur nom, leurs coordonnées et l'âge de leur(s) enfant(s), afin qu'ils puissent recevoir des messages pertinents selon l'âge de leur enfant.

Soutenir les comportements parentaux, la recherche de soutien et le bien-être tout au long de la vie

L'annexe 1 illustre par des exemples la manière dont les services de santé peuvent soutenir les personnes en charge d'un enfant à différents stades du développement de leur enfant, depuis la période prénatale jusqu'à l'adolescence. Ces exemples et priorités sont tirés des orientations et des ressources publiées par l'Organisation mondiale de la Santé (figure 3). La liste exhaustive des publications pertinentes est fournie à l'annexe 2.



Figure 3. Aperçu des ressources proposées par l'OMS pour venir en aide aux parents et aux personnes en charge d'un enfant tout au long de la vie



Conclusion

Pour soutenir les parents et les aidants, les systèmes de santé devraient :

- insister sur la promotion de relations de soutien avec les parents et les personnes en charge d'un enfant
- reconnaître les forces déjà présentes chez les personnes s'occupant d'un enfant et répondre dans les domaines où un soutien est nécessaire.
- fournir des services de soutien et des orientations en fonction des besoins, tout au long de la vie

Tous les parents et les personnes en charge d'un enfant ont besoin d'un système de santé qui leur offre des services de qualité pour les accompagner dans leur parcours de parentalité. Les prestataires de services de santé jouent un rôle important car ils présentent et renforcent les pratiques essentielles en matière de soins dans le but d'améliorer la santé et le bien-être des enfants, des adolescents et des personnes qui s'occupent d'eux.

Références bibliographiques

1. OMS, UNICEF. Amélioration de la santé et du bien-être des enfants et des adolescents : orientations relatives aux visites médicales planifiées pour les enfants et les adolescents. Genève : Organisation mondiale de la santé ; 2023. (<https://iris.who.int/items/784789d0-bee5-45fa-871f-e86b45d4c9b7>, consulté le 1er avril 2025).
2. Lignes directrices de l'OMS sur les programmes de responsabilisation parentale visant à prévenir la maltraitance et à améliorer les relations parent-enfant chez les enfants âgés de zéro à 17 ans. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2022. (<https://iris.who.int/handle/10665/375980>, consulté le 1er avril 2025).
3. Cluver LD, Meinck F, Steinert JI, Shenderovich Y, Doubt J, Romero RH, et al. Parenting for Lifelong Health: a pragmatic cluster randomised controlled trial of a non-commercialised parenting programme for adolescents and their families in South Africa. *BMJ Global Health* 2018;3(e000539).
4. Olds DL, Eckenrode J, Henderson CR, Kitzman H, Powers J, Cole R, et al. Long-term effects of home visitation on maternal life course and child abuse and neglect: fifteen-year follow-up of a randomized trial *JAMA* 1997;278:8, 637–43.
5. Parenting support framework for the early years. Genève : Bureau régional de l'UNICEF pour l'Europe et l'Asie centrale ; 2024. (<https://www.unicef.org/eca/reports/parenting-support-framework-early-years>, consulté le 1er avril 2025).
6. OMS, UNICEF, Groupe de la Banque mondiale. Soins attentifs pour le développement de la petite enfance : un cadre pour aider les enfants à survivre et à s'épanouir afin de transformer la santé et le potentiel humain. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2018.
7. Operationalizing nurturing care for early childhood development: the role of the health sector alongside other sectors and actors. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2019. (<https://iris.who.int/handle/10665/335708>, consulté le 1er avril 2025).

Élaboration du présent document

Pour élaborer ce document, un groupe de travail interdépartemental de l'OMS a été constitué, avec des représentants et représentantes du Département Santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et

de l'adolescent, et vieillissement (MCA) ; du Département Santé mentale, santé cérébrale et usage de substances psychoactives (MSD) ; du Département Déterminants sociaux de la santé (SDH) ; et de l'Unité des connaissances comportementales (BI). Les représentants et représentantes ont partagé leur expertise pertinente et les publications de l'OMS dans le but de déterminer la portée du document. L'absence de conflit d'intérêts une fois établie, l'Université de Stellenbosch a été engagée pour élaborer le contenu en s'appuyant sur les orientations normatives existantes de l'OMS et les publications techniques recensées par le groupe de travail interdépartemental de l'OMS. Le personnel de l'OMS dans les six bureaux régionaux ainsi que le personnel de l'OMS et les partenaires gouvernementaux de six pays (Colombie, Jordanie, Kazakhstan, Philippines, République-Unie de Tanzanie et Thaïlande) qui entreprennent des activités visant à promouvoir le soutien aux parents et aux personnes en charge d'un enfant, avec le secteur de la santé et par son intermédiaire, ont été invités à donner leur avis sur le document en ligne ou en présentiel. La consultation en ligne a eu lieu en novembre 2024 et la consultation en présentiel en février 2025 (Amman, Jordanie). Le groupe de travail interministériel de l'OMS susmentionné a pris les décisions finales concernant le document.

Remerciements

Ce document a été coordonné par le Département Santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent, et vieillissement (MCA) de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) en collaboration avec le Département Santé mentale, santé cérébrale et usage de substances psychoactives (MSD), le Département Déterminants sociaux de la santé (SDH) et l'Unité des connaissances comportementales (BI). Sheila Manji (MCA) a supervisé l'élaboration de ce document, avec le soutien technique de Prerna Banati (MCA), Alexander Butchart (SDH), Timothy Chadborn (BI), Ammaarah Martinus (BI), Sabine Rakotomalala (SDH), Chiara Servilli (MSD) et Sarah Skeen (MSD).

L'OMS remercie chaleureusement Marguerite Marlow et Mark Tomlinson (Institute for Life Course Health Research, Université de Stellenbosch, Afrique du Sud) pour avoir élaboré le contenu de ce document.

L'OMS adresse en outre ses remerciements aux personnels de l'OMS dans les bureaux régionaux et les bureaux de pays pour leur lecture et leurs commentaires : Colombie : Evelyne Ancion Degraff et Martha Juliana Iregui ; Jordanie : Ghada Alkayyali, Alaa Alzaghouel et Mohammed Al-Emad ; Kazakhstan : Akbota Abildina et Laura Utemissova ; Philippines : Emma Callon, April Joy David, Isabel Constance Espinosa et John Juliard Go ; Thaïlande : Olivia Corazon Nieveras et Thanatporn Rawanghet ; République-Unie de Tanzanie : Mary Theophil Kessi et Neema Kileo ; Bureau régional de l'Afrique : Janet Kayita, Ismail Ali Oumalkhair, Chiara Retis et Binta Sako ; Bureau régional des Amériques : Britta Baer, Sonja Caffé et Matias Irrazaval ; Bureau régional de l'Asie du Sud-Est : Andrea Bruni, Suvajee Good et Rajesh Khanna ; Bureau régional de l'Europe : Sophie Jullien, Ledia Lazeri et Jonathon Passmore ; et Bureau régional de la Méditerranée orientale : Wafaa Elsayy, Anna Rita Ronzoni, Hala Sakr Ali, Khalid Saeed et Khalid Siddeeq.

L'OMS remercie également les pairs examinateurs externes pour leurs précieux commentaires : Hadeel Al-Sayyeh, Ministère de la santé, Jordanie ; Tamara Al-Zoubi, Conseil national des affaires familiales, Jordanie ; Dulce Cecilio Elfa, Ministère de la santé, Philippines ; Areej Hijjawi, Ministère de la santé, Jordanie ; Zhuldyzay Iskakova, Commission nationale pour les affaires féminines, la famille et la politique démographique, Kazakhstan ; Beauty Mwanyesya Mwambebule, Ministère de la santé, République-Unie de Tanzanie ; Chumphot Phromsida, Ministère de la santé publique, Thaïlande ; Victor Richard Rugarabamu, Ministère du développement communautaire, de l'égalité des sexes, des femmes et des groupes spéciaux, République-Unie de Tanzanie ; Gulnaz Sagimbayeva, Institut national scientifique et pratique pour la protection de l'enfance « Orken », Kazakhstan ; Yanika Valeettikul, Ministère de la santé publique, Thaïlande ; et Magripa Yembergenova, Ministère de la santé, Kazakhstan.

L'élaboration de ce document a été soutenue par l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) (Accord 7200GH21IO000005) et la Fondation LEGO. Son contenu relève de la responsabilité de l'OMS et ne reflète pas nécessairement les points de vue de l'USAID ou du Gouvernement des États-Unis d'Amérique.

Exemples de soutien aux aidants tout au long de la vie et priorités pour les prestataires de services

Les services de santé courants (dans les établissements de santé ou dans la communauté) permettent de renforcer les comportements parentaux, de promouvoir la recherche de soutien et de favoriser le bien-être des personnes en charge d'un enfant. Utiliser les services existants pour fournir des informations qui peuvent permettre aux aidants de favoriser la santé, le développement et le bien-être des enfants et des adolescents ; développer et renforcer les connaissances et les compétences parentales des personnes en charge d'un enfant ; écouter les préoccupations des aidants ; et faciliter les liens avec les services pertinents en cas de besoin.



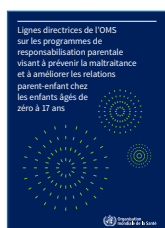
Renforcer les comportements parentaux	Promouvoir la recherche de soutien	Favoriser le bien-être des aidants
À TOUS LES STADES		
• Fournir des informations sur ce à quoi s'attendre à mesure que les enfants et les adolescents/adolescentes grandissent et se développent, et sur la manière dont les personnes qui s'occupent d'eux peuvent les aider au mieux à traverser les changements qui surviennent à toutes les étapes de la vie. • Développer et renforcer les connaissances et les compétences des personnes qui s'occupent d'un enfant à tous les stades de développement. • Renforcer la confiance des personnes dans leurs compétences parentales en confirmant leurs capacités et en saluant les mesures qu'elles prennent pour accompagner le développement de leurs enfants et adolescents. • Donner aux personnes les moyens de fournir des soins attentifs et appropriés à leurs enfants et adolescents à mesure de leur développement	• Demander aux personnes qui s'occupent d'un enfant si elles ont des inquiétudes au sujet de la santé, du développement et du bien-être de leur enfant ou adolescent/adolescente. • Informer les personnes qui s'occupent d'un enfant des services auxquels elles peuvent avoir accès pour obtenir un soutien supplémentaire et faciliter l'orientation vers des services de santé ou des services autres que le secteur de la santé, au besoin. • Repérer tout signe d'agressivité parentale ou de maltraitance d'enfants ou de défaut de soins et fournir un soutien tout en facilitant l'accès aux services de protection de l'enfance au besoin.	• Demander aux personnes qui s'occupent d'un enfant comment elles s'en sortent et si elles ont des inquiétudes au sujet de leur santé mentale ou de leur bien-être. • Chercher à savoir s'il y a des risques pour le bien-être, tels que l'usage de substances ou un stress élevé. • Répondre aux préoccupations des personnes qui s'occupent d'un enfant et faciliter l'accès à des soins de santé mentale supplémentaires au besoin.

Renforcer les comportements parentaux	Promouvoir la recherche de soutien	Favoriser le bien-être des aidants
PÉRIODE PRÉNATALE (GROSSESSE)		
- Fournir des informations sur les avantages d'une bonne alimentation, de la réduction du stress et d'un mode de vie sain pendant la grossesse pour la mère et l'enfant. - Favoriser l'établissement de la relation affective et l'attachement, par exemple attirer l'attention sur la capacité du bébé à reconnaître la voix au cours du troisième trimestre de la grossesse.	Donner des renseignements sur les informations et le soutien prénatals disponibles et mettre les personnes qui s'occupent de l'enfant en contact avec ces programmes.	Identifier et renforcer les possibilités d'améliorer la participation du partenaire et de la famille aux soins prénatals.
PÉRIODE NÉONATALE ET PREMIÈRE ENFANCE (DE LA NAISSANCE À 11 MOIS)		
- Fournir des informations sur le développement des enfants en mettant l'accent sur ce à quoi s'attendre dans tous les domaines du développement et sur la façon dont les personnes qui s'occupent de l'enfant peuvent soutenir le développement de ce dernier. - Favoriser l'établissement de la relation affective et l'attachement entre la personne qui s'occupe du bébé et ce dernier. - Donner des exemples de réponses chaleureuses et positives aux pleurs du bébé. - Renforcer la confiance et la compétence des personnes qui s'occupent du bébé pour qu'elles comprennent les signaux et besoins de ce dernier, et y répondent.	- Demander aux personnes qui s'occupent de l'enfant si elles ont des inquiétudes concernant le retour à la maison, les écouter et répondre à ces craintes en faisant preuve d'empathie et de soutien. - Prodiguer des conseils à la mère sur l'allaitement maternel et les habitudes alimentaires saines et sur la façon d'obtenir un soutien supplémentaire si nécessaire. - Expliquer comment s'apercevoir que le nourrisson est malade, et comment et quand demander de l'aide.	- Mettre en place des liens de qualité entre les services de santé de l'enfant et les services de soins périnatals ou de santé mentale des personnes qui s'occupent d'un enfant. - Expliquer à la personne qui s'occupe de l'enfant, à son partenaire et à la famille comment reconnaître les problèmes de santé mentale périnatale ou de santé mentale des personnes qui s'occupent d'un enfant et comment accéder à des soins de santé mentale supplémentaires au besoin.
PETITE ENFANCE (1-4 ans)		
- Expliquer comment favoriser le développement de l'enfant, y compris en prêtant attention à la sécurité, en instaurant des routines et en entretenant une relation chaleureuse. - Renforcer la confiance des personnes qui s'occupent d'un enfant afin qu'elles proposent des activités adaptées au développement de l'enfant et interagissent avec lui de manière réactive. - Montrer comment les activités quotidiennes peuvent contribuer à l'apprentissage de l'enfant. - Parler des techniques de discipline positive et montrer comment les utiliser. - Donner des exemples de réponses empathiques et bienveillantes, par exemple si l'enfant a peur de l'aiguille pendant la vaccination.	Poser des questions sur les inquiétudes de la personne qui s'occupe de l'enfant (santé, développement, bien-être) et y répondre en faisant preuve d'empathie et de soutien, et faciliter l'orientation vers des services supplémentaires au besoin.	- Se renseigner sur la situation de la personne ayant la charge de l'enfant et sur son expérience en la matière et faciliter l'accès à un soutien supplémentaire si nécessaire. - Prendre en compte les frustrations de la personne qui s'occupe de l'enfant vis-à-vis du comportement de l'enfant, et faire preuve d'empathie à cet égard, et normaliser ou contextualiser les comportements difficiles de l'enfant.

Renforcer les comportements parentaux	Promouvoir la recherche de soutien	Favoriser le bien-être des aidants
FIN DE L'ENFANCE (5-9 ans)		
- Donner aux personnes qui s'occupent d'un enfant les moyens de créer des environnements sûrs en expliquant comment réduire l'exposition aux risques pendant l'enfance. - Féliciter les personnes ayant la charge d'un enfant pour l'attention qu'elles portent au développement de leur enfant, par exemple pour avoir exprimé leurs inquiétudes lors des examens de la vision, de l'audition ou de l'état de préparation à l'école, et/ou pour avoir favorisé les compétences sociales et émotionnelles de leur enfant. - Fournir des conseils sur les approches positives de la discipline, y compris l'instauration de limites, les règles et les conséquences de leur non-respect, et les activités visant à stimuler le développement social et émotionnel.	- Se renseigner sur les stades de développement, la période de transition avec l'entrée à l'école, le comportement et le fonctionnement à l'école, et répondre à toutes les inquiétudes des personnes qui s'occupent d'un enfant en faisant preuve d'empathie et de soutien, et faciliter l'orientation vers des services supplémentaires au besoin. - Faciliter la communication et l'échange d'informations avec les établissements scolaires et les services de protection, au besoin.	- Se renseigner sur l'expérience de la personne qui s'occupe de l'enfant en matière de soins, en particulier lorsque l'enfant présente des troubles du développement, des difficultés sociales ou émotionnelles, des maladies chroniques ou des handicaps - Prendre en compte les inquiétudes de la personne qui s'occupe de l'enfant, et faire preuve d'empathie à cet égard, et faciliter l'accès à un soutien supplémentaire au besoin.
ADOLESCENCE (10-19 ans)		
- Donner des informations sur les changements développementaux attendus. - Donner des exemples ou prodiguer des conseils aux parents sur les compétences et les stratégies adaptées au développement de leurs adolescents afin de pouvoir répondre aux besoins de ces derniers à mesure qu'ils grandissent. - Donner aux personnes qui s'occupent d'un adolescent ou d'une adolescente les moyens de créer des environnements sûrs en réduisant l'exposition aux risques. - Expliquer aux personnes qui s'occupent d'un adolescent ou d'une adolescente comment discuter de questions délicates avec eux, notamment les changements liés à la puberté, la santé menstruelle, le genre, la santé sexuelle, la santé mentale et l'usage de substances. - Améliorer les connaissances des prestataires de soins sur la façon d'encourager les adolescents à adopter des comportements sains, y compris les stratégies de réduction des risques et les comportements de protection. - Tenir compte du consentement de l'adolescent ou de l'adolescente et de la confidentialité lors des entrevues et des examens physiques en présence des personnes qui s'occupent d'eux.	- Se renseigner sur le comportement et le fonctionnement scolaire de l'adolescent ou de l'adolescente et fournir des informations à ce sujet. - Répondre aux inquiétudes exprimées par les personnes qui s'occupent de l'adolescent ou l'adolescente, par ce dernier ou cette dernière, ou par ses enseignants et enseignantes, et faciliter l'orientation vers des services supplémentaires au besoin. - Faciliter l'établissement de liens entre les soins de santé primaires, les services de santé adaptés aux jeunes et les services de santé scolaire.	- Se renseigner sur l'expérience parentale de la personne qui s'occupe de l'enfant pendant la période de l'adolescence. - Explorer les besoins spécifiques des parents d'adolescents ayant des problèmes de santé mentale, des maladies chroniques ou des handicaps. - Prendre en compte les inquiétudes de la personne qui s'occupe de l'adolescente ou de l'adolescent, et faire preuve d'empathie à cet égard, et faciliter l'accès à un soutien supplémentaire au besoin.

Ressources pour chaque stade de développement

À TOUS LES STADES



Lignes directrices sur les programmes de responsabilisation parentale (0-17 ans)

Lignes directrices de l'OMS sur les programmes de responsabilisation parentale visant à prévenir la maltraitance et à améliorer les relations parent-enfant chez les enfants âgés de zéro à 17 ans (OMS, 2022)



Manuel sur les programmes de responsabilisation parentale (0-17 ans)

Designing, implementing, evaluating and scaling up parenting interventions: a handbook for decision-makers and implementers (OMS, 2024)



Cadre INSPIRE (0-17 ans)

INSPIRE : sept stratégies pour mettre fin à la violence à l'encontre des enfants. Une trousse reposant sur des données factuelles pour prévenir la violence à l'encontre des enfants et y riposter (OMS, 2016)



Orientations relatives aux visites médicales planifiées (0-19 ans)

Amélioration de la santé et du bien-être des enfants et des adolescents : orientations relatives aux visites médicales planifiées pour les enfants et les adolescents.



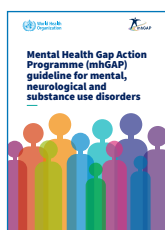
Manuel INSPIRE (0-17 ans)

INSPIRE handbook: action for implementing the seven strategies for ending violence against children (OMS, 2018)



Intervenir en cas de maltraitance des enfants (0-17 ans)

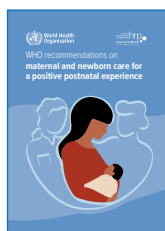
Intervenir en cas de maltraitance des enfants : manuel clinique destiné aux professionnels de santé (OMS, 2022)



mhGAP guideline for mental, neurological and substance use

Guidance for delivering delivering MNS interventions by health workers (OMS, 2023)

PÉRIODE PRÉNATALE (GROSSESSE), PÉRIODE NÉONATALE ET PETITE ENFANCE (DE LA NAISSANCE À 11 MOIS)



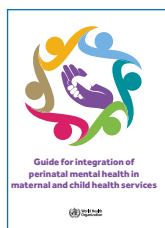
Soins de la mère et du nouveau-né

WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience (OMS, 2022)



Méthode « mère kangourou »

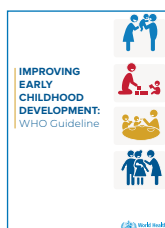
Méthode « mère kangourou » : une innovation transformatrice en matière de soins de santé : document de position mondial (OMS, 2023)



Santé mentale périnatale

Guide for integration of perinatal mental health in maternal and child health services (OMS, 2022)

PETITE ENFANCE (1-4 ANS)



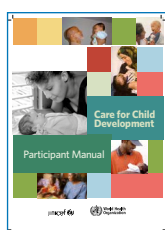
Improving early childhood development (0-3 ans)

Lignes directrices de l'OMS fournissant des recommandations mondiales fondées sur des données probantes pour améliorer le développement de la petite enfance (OMS, 2020)



Cadre de soins attentifs (0-3 ans)

Soins attentifs pour le développement de la petite enfance : un cadre pour aider les enfants à survivre et à s'épanouir afin de transformer la santé et le potentiel humain (OMS, 2018)



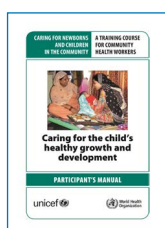
Care for child development (0-3 ans)

Cours sur les conseils à la famille sur les soins du développement de l'enfant : Manuel du participant (OMS, 2012)



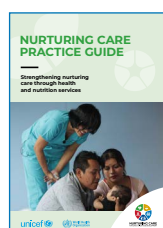
Soins attentifs pour le développement de la petite enfance (0-3 ans)

Operationalizing nurturing care for early childhood development: the role of the health sector alongside other sectors and actors (OMS, 2019)



Caring for the child's healthy growth and development (0-3 ans)

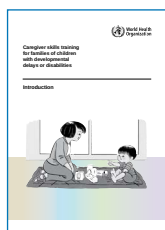
Caring for newborns and children in the community: a training course for community health workers (OMS, 2015)



Nurturing Care Practice Guide (0-3 ans)

Nurturing care practice guide: strengthening nurturing care through health and nutrition services (OMS, 2022)

FIN DE L'ENFANCE (5-9 ANS)



Formation sur les compétences des personnes qui s'occupent d'un enfant (2-9 ans)

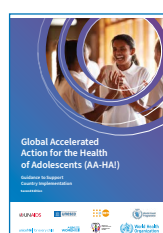
Caregiver skills training for families of children with developmental delays or disabilities (OMS, 2022)

ADOLESCENCE (10-19 ANS)



Compétences émotionnelles chez les jeunes adolescents (10-15 ans)

Compétences émotionnelles chez les jeunes adolescents : Aide psychologique de groupe pour les jeunes adolescents touchés par un sentiment de détresse dans les communautés exposées à l'adversité (OMS, 2023)



AA-HA ! (10-19 ans)

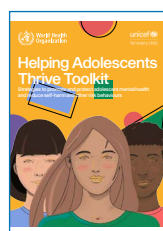
Action mondiale accélérée en faveur de la santé des adolescents (AA-HA!)

Orientations à l'appui de la mise en œuvre dans les pays (OMS, 2023)



Santé des adolescents (10-19 ans)

WHO recommendations on adolescent health (OMS, 2017)



Aider les adolescents à s'épanouir (10-19 ans)

Helping adolescents thrive toolkit: strategies to promote and protect adolescent mental health and reduce self-harm and other risk behaviours (OMS, 2021)

POUR PLUS D'INFORMATIONS

<https://www.who.int/initiatives/supporting-parents>

<https://support-parents.org>

CONTACTS

mncah@who.int

mentalhealth@who.int

violenceprevention@who.int



Une mère et sa jeune fille jouent dans un établissement de santé en Colombie.
© International Rescue Committee/A Brenner